

Ich habe die Prüfung am 21.04.2026 im RBK abgelegt und alhamdulillah bestanden.

(4/4 bestanden)

Antrag und Termin :

Antrag: 15.12

Warteliste: 14.01

Gebührenbescheid: 19.02

Bezahlt: 20.02

Einladung: 26.02

Termin: 21.04 (RBK)

Kommission

Die Kommission bestand aus drei sehr freundlichen Ärzten, die sehr hilfsbereit waren und uns während der Prüfung gut unterstützt haben.

Ablauf der Prüfung

Um 8:45 Uhr wurden wir abgeholt.

Im Konferenzraum wurde uns der Prüfungsablauf erklärt, und jeder bekam ein Notizbuch und einen Stift.

Teil 1:

Um 9:00 Uhr auf Station – jeder bekommt einen Patienten.

Um 9:30 Uhr zurück in den Konferenzraum.

Teil 2:

Von 9:45 bis 11:15 Uhr: Brief schreiben.

Teil 3:

Um 12:00 Uhr wieder auf Station bis ca. 13:00 Uhr.

Jeder geht einzeln mit den Prüfern ins Patientenzimmer, die anderen warten draußen.

Danach wieder in den Konferenzraum.

Teil 4:

Von ca. 13:00 bis 16:00 Uhr:

Alle sitzen zusammen, und jeder Prüfer stellt einem von uns für etwa 15 Minuten Fragen, dann ist der Nächste dran.

Das bedeutet, dass wir die Fragen der anderen hören und warten, bis wir selbst dran sind.

Das Ganze hat etwa 3 Stunden gedauert – wirklich lang!

Danach haben wir draußen gewartet und schließlich die guten Nachrichten erhalten.

Prüfung

Teil 1

Patientin aus der Pulmonologie:

67 Jahre alt

Sie wurde wegen progredienter Dyspnoe und ausgeprägter generalisierter Ödeme im Sinne einer Anasarka aufgenommen.

Verdachtsdiagnose:

Dekompensierte pulmonale Hypertonie mit Rechtsherzbelastung und Anasarka im Rahmen einer Kollagenose

Vorerkrankungen:

- Kollagenose (vermutlich Sklerodermie) seit 20 Jahren
- Pulmonale Hypertonie seit etwa 7 Jahren
- Arterielle Hypertonie

Medikamente:

- Tadalafil
- Remodulin (über eine Pumpe im Abdomen)
- Diuretika (Furosemid und Torasemid)
- Ramipril

Klinische Untersuchung:

- AZ deutlich reduziert
- HF 100/min
- AF 30/min

- Zahnschiene
- Tachykard, dyspnoisch, zyanotische Lippen
- Auskultatorisch: basale Rasselgeräusche und 3. Herzton
- Abdomen: stark gebläht, Pumpe unter der Haut tastbar, reizlose verheilte Narbe
- Extremitäten: stark ausgeprägte, eindrückbare, schmerzhaft Ödeme (Godet positiv, Stimmfremitus negativ)
- Gelenkschwellungen der DIP-Gelenke, Teleangiektasien im Gesicht
- Anasarka (Ödeme im Gesicht, an Brust und Extremitäten) sowie Aszites

Teil 2

Brief schreiben (90 Minuten)

Ich habe alles geschrieben, außer der Therapie (die Zeit war leider um). In der Pause habe ich diesen Teil noch einmal auf ein Stück Papier geschrieben und ihn dann bei der Präsentation vorgelesen.

Teil 3

Ich habe fast alles aus dem Brief vorgelesen (mit einigen Umformulierungen).

Danach sollte ich die pulmonale Untersuchung durchführen, die Befunde interpretieren und weitere Fragen dazu beantworten, z. B. zu Perkussion, Stimmfremitus und Rasselgeräuschen sowie möglichen Befunden und den dazugehörigen Erkrankungen.

Teil 4

„Achtung: Was hier steht, dient nur als Beispiel dafür, wie es sein sollte! Natürlich habe ich nicht alle Fragen perfekt beantwortet, aber die Prüfer helfen uns immer, den richtigen Weg zu finden.“

Prüfer 1 :

Fall 1 :

Akutes Abdomen

Vorgehen bei akutes Abdomen :

VP überprüfen und bei Instabilen Patienten nach ABCDE Schema vorgehen.

Ansonsten : Anamnese, KU, Labor, Bildgebung...

Befund : Bei der Bauchuntersuchung tastbarer pulsierender Tumor.

Verdachtsdiagnose?

Bauchaortenaneurysma (AAA)

Bildgebung : 2 CT bilder : Was sehen Sie ?

CT 1: Rupturiertes Aortenaneurysma mit freier Flüssigkeit (Blut) im Abdomen → Patientin instabil

CT 2: Nicht rupturiertes Aneurysma zum Vergleich

Therapie ?

Notfalltherapie bei rupturiertem AAA

Optionen ?

Endovaskuläre Versorgung = EVAR

Offen-chirurgische Versorgung

Fall 2 :

Patient, jung, kommt mit Schmerzen im rechten Unterbauch und Fieber.

Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?

Verdacht auf Appendizitis.

Was berichten Patienten typischerweise in der Anamnese?

Typischerweise beginnen die Schmerzen periumbilikal und wandern dann in den rechten Unterbauch.

Wie gehen Sie diagnostisch vor?

Anamnese

Körperliche Untersuchung

Labor: Entzündungsparameter (z. B. Leukozyten, CRP)

Bildgebung: Sonografie

Dann habe ich eine Sono bekommen

Was sehen Sie?

Kokardenphänomen (Target-Zeichen), typisch für eine Appendizitis.

Therapie : Appendektomie

Konservativ ? ja möglich mit ATB

Das selbe Bild, Patient alt ! keine Appendizitis was kann das sei das wir nicht unbedingt operieren werden und normalerweise links ist ?

Divertikulitis !

Fall 3 :

Akutes Abdomen

Wie gehen Sie generell beim akuten Abdomen vor?

Erste Schritt : Überprüfung der Vitalparameter (stabil vs. instabil) usw.

Patientin mit Oberbauchschmerzen und Fieber – Ihre Verdachtsdiagnose?

Akute Cholezystitis.

Welche typischen Zeichen gibt es?

Murphy-Zeichen.

Was ist das Murphy-Zeichen?

Schmerzbedingter Abbruch der Inspiration bei Palpation im rechten Oberbauch im Bereich der Gallenblase.

Welche Laborwerte bestimmen Sie?

Entzündungsparameter (CRP, Leukozyten)

Leberparameter (AST, ALT, γ -GT, AP, Bilirubin)

Welche Bildgebung führen Sie durch?

Sonografie des Abdomens.

Was sehen Sie in der Sonografie?

Verdickte Gallenblasenwand mit Dreischichtung

(Bei diesem Bild waren Keine Steine nachweisbar!)

Wie therapieren Sie die Patientin?

Antibiotische Therapie + Cholezystektomie

Die Patientin entwickelt einige Tage später einen Ikterus. Was denken Sie?

Verdacht auf Choledocholithiasis oder Abflussstörung im Ductus choledochus.

Es zeigt sich kein Stein. Was ist eine mögliche Ursache?

Iatrogene Komplikation: versehentliche Verletzung oder Ligatur des Ductus choledochus während der Operation.

Wie therapieren Sie das?

Operative Versorgung mit Wiederherstellung des Gallenabflusses.

Wie heißt dieses Verfahren?

Biliodigestive Anastomose.

Falls es ein Stein wäre ?

ERCP

Fall 4 :

Patient in der Notaufnahme mit starken Oberschenkel Schmerzen.

Risikofaktoren: Alkoholabusus und Diabetes mellitus.

Klinisch: sehr starke Schmerzen, Hautveränderungen bis hin zu Nekrosen und Hautablösungen

Verdachtsdiagnose ?

Nekrotisierende Faszitis

Dann bekomme ich ein CT Bild

Was sehen Sie ?

CT des betroffenen Areals (Nachweis von Ausdehnung und Gas im Gewebe).

Therapie ?

Sofortige chirurgische Sanierung mit radikalem Débridement, ggf. wiederholte Eingriffe.

Breitspektrum-Antibiotikatherapie (Piperacillin/Tazobaktam + Clindamycin)

Intensivmedizinische Betreuung.

Prüfer 2 :

Fall 1 :

Patientin mit Blutdruckwerten von 150/80 mmHg.

Vorgehen?

Blutdruckmessung unter Ruhebedingungen wiederholen, Messung an beiden Armen (Hinweis auf mögliche Gefäßpathologien wie z. B. Aortenisthmusstenose).

Anamnese (Risikofaktoren, Begleiterkrankungen, Medikamente).

Körperliche Untersuchung.

24-Stunden-Blutdruckmessung zur Bestätigung der Diagnose.

Laboruntersuchungen.

Einteilung ?

Primäre (essenzielle) Hypertonie: ca. 90 %

Sekundäre Hypertonie: ca. 10 %

Ursachen der sekundären Hypertonie?

Renal: Nierenarterienstenose, chronische Nierenerkrankung

Endokrin: Phäochromozytom, Cushing-Syndrom, primärer

Hyperaldosteronismus (Conn-Syndrom), Hyperthyreose

Schlafapnoesyndrom

Screening bei Schlafapnoe ?

Polysomnographie.

Therapie ?

1. Lebensstilveränderungen:

Gewichtsreduktion

Kochsalzreduktion

Regelmäßige körperliche Aktivität

Alkoholreduktion

Rauchstopp

Gesunde Ernährung (z. B. mediterrane Kost)

Stressreduktion

Medikamentöse Therapie ?

ACE-Hemmer oder AT1-Rezeptorblocker (Sartane)

Kalziumkanalblocker

Thiazid-/thiazidartige Diuretika

Betablocker (bei spezifischen Indikationen)

Indikationen für Betablocker ?

Koronare Herzkrankheit

Zustand nach Myokardinfarkt

Herzinsuffizienz

Tachyarrhythmien

Nebenwirkungen ?

ACE-Hemmer : Reizhusten, Hyperkaliämie, Angioödem

AT1-Blocker (Sartane) : Hyperkaliämie, selten Schwindel

Kalziumkanalblocker : Periphere Ödeme (v. a. an den Beinen),

Kopfschmerzen, Flush

Diuretika : Elektrolytstörungen (z. B. Hypokaliämie), Dehydratation

Betablocker : Bradykardie, Müdigkeit, Bronchokonstriktion

Fall 2 :

EKG

ST-Hebungen im II - III - aVF = STEMI (Hinterwandinfarkt)

Vorgehen ?

MONAH + Anruf an Herzkatheterlabor !

Prüfer 3 :

Fall 1 :

Patient mit Hämatemesis

Geschichte : Alkohol, Lebererkrankung, NSAR

Vorgehen ?

Akutmanagement mit Stabilisierung (Vitalparameter, Volumen, ggf. Blutprodukte).

Labor (Hb, Gerinnung, Leberwerte).

Endoskopie zur Blutungssuche.

Verdachtsdiagnose?

OGIB im Rahmen einer portalen Hypertension bei Leberzirrhose

Pathophysiologie ?

Leberzirrhose → portale Hypertonie → Ausbildung von Kollateralen (z. B. Ösophagus- oder Fundusvarizen) → Blutungsquelle möglich.

Diagnostik?

Gastroskopie (Varizen?)

Therapie ?

Volumen, Bluttransfusionen

Varizenblutung: Terlepressin, endoskopische Ligatur, Ceftriaxon

Warum Ceftriaxon : Prophylaxe gegen spontane bakterielle Peritonitis

Fall 2 :

Patient Bewusstlosigkeit, keine normale Atmung, kein Puls tastbar

Sofortiges Vorgehen ?

Notruf / Reanimationsteam alarmieren

Sie sind Notarzt! Was machen Sie ?

- ABC-Check
- Beginn der Herzdruckmassage (30:2 bzw. kontinuierlich bei Intubation)
- Sauerstoffgabe, Beatmung
- Monitoring (EKG, SpO₂)
- Rhythmusanalyse: Schockbarer Rhythmus (Kammerflimmern / pulslose VT) oder Nicht-schockbarer Rhythmus (Asystolie / PEA)
- Bei schockbarem Rhythmus (VF / pVT): Defibrillation (1 Schock) sofortige CPR für 2 Minuten, Adrenalin alle 3–5 Minuten und Amiodaron nach 3. Schock

- Bei nicht-schockbarem Rhythmus (Asystolie / PEA): keine Defibrillation, sofort CPR, Adrenalin alle 3–5 Minuten

Ursachen?

4H / 4T

H: Hypoxie, Hypovolämie, Hypo-/Hyperkaliämie, Hypothermie

T: Tamponade (Herzbeutel), Thrombose (Lungenembolie/KHK), Toxine, Spannungspneumothorax

Zusatzfragen

Wie überprüfen Sie die Atmung?

Für maximal 10 Sekunden: sehen, hören und fühlen

Sehen: Thoraxbewegung

Hören: Atemgeräusche

Fühlen: Luftstrom an der Wange

Airway-Management – was machen Sie?

Endotracheale Intubation (Goldstandard)

Alternativ: supraglottische Atemwegshilfen (Larynxmaske / Larynextubus)

Wie tief drücken Sie bei der Herzdruckmassage?

5–6 cm bei Erwachsenen

Wie viel Joule beim Defibrillieren?

Biphasisch: meist 150–200 Joule initial (je nach Gerät)

Fall 3 :

BGA

Fio₂ : 50%

pH : 7,52

O₂ 59 mmHg

CO₂ 25 mmHg

HCO₃ 26 mmol/L

Interpretation ?

Hypoxämie bei erniedrigtem CO₂ → Hinweis auf Hyperventilation unter Beatmung.

Säure-Basen-Status:

→ respiratorische Alkalose (wahrscheinlich beatmungsbedingt durch zu

hohe Ventilation)

Vorgehen ?

Anpassung der Beatmungsparameter

(Ich habe die FiO_2 am Anfang nicht gesehen! Nur BGA als Resp. Alkalose interpretiert, dsnn bekomme ich hinweise habe ich die FiO_2 gesehen und gesagt das der Patient beatmet ist usw.)

Was wurde aus PaO_2 und FiO_2 berechnet ?

Horowitz-Quotient

Wofür wird er verwendet?

Zur Beurteilung der Oxygenierungsstörung

Bei Unseren Patient ? zwischen 100–200

Was bedeutet ein niedriger Horowitz-Quotient?

→ Schwere Oxygenierungsstörung, z. B. bei ARDS, Pneumonie, Lungenödem, Sepsis-induzierter Lungenschädigung...

Vorbereitung

- FIA-Kurs (Abendkurs, 6 Monate)
- Amboss-KP-Plan
- Last Minute Pharmakologie
- EKG 60 Fälle
- Protokolle
- Simulationen
- ChatGPT

Ich möchte betonen, dass ich keine praktische Erfahrung habe und keine Hospitation oder Ähnliches gemacht habe.

Ich habe mich insgesamt 10 Monate intensiv vorbereitet:

- 6 Monate FIA-Kurs
- 2 Monate Wiederholung
- Die letzten 2 Monate: Protokolle durchgearbeitet und Simulationen gemacht (alle aus dem RBK)

Die Prüfung ist zwar nicht einfach, aber machbar.

Wenn man gut vorbereitet ist, kann man sie bestehen.

Vielen Dank an alle, die ihre Protokolle teilen – das ist unglaublich hilfreich!

Tips !

Wenn Sie ein Thema lernen, sollten Sie immer strukturiert vorgehen:
Lernen Sie zuerst die Definition, anschließend Ursachen und Risikofaktoren usw.

Dann überlegen Sie:

Welche Anamnese-Fragen stelle ich?

Welche Symptome sind typisch?

Was finde ich bei der klinischen Untersuchung?

Welche Laborwerte sind relevant?

Welche Bildgebung (z. B. Röntgen, CT) ist sinnvoll?

Welche Therapie wird durchgeführt?

Welche Wirkmechanismen haben die Medikamente?

Welche Nebenwirkungen (NW) und Kontraindikationen (KI) gibt es?

Welche OP ? Welche Möglichkeiten? Welche Komplikationen ?

Üben Sie außerdem immer fallbasiert, als wären Sie im Krankenhaus :

Was berichten die Patienten?

Wie präsentiert sich der Patient klinisch?

Welche Befunde sind möglich?

Schauen Sie sich typische Laborwerte und Bildgebung an.

Wie sieht z. B. ein CT-Bild aus?

Geben Sie konkrete Therapiebeispiele an.

BONUS :

Ich habe während der Letzten 2 Monaten für RBK folgende Themen intensiv vorbereitet (basiert auf die Protokollen)

	Kadio - Vx Thrombektomie Kompartiment Sd AAV pAVK TVT LAE Aortendissektion Aneurysma Ao. Syndrom/Ao Ulkus KHK Bypass ACS Herzklappenerkrankungen AS AI MI MS TI Kardio HF Kardiomyopathie aHt Hypertensive Notfall/Entgleisung Endokarditis Perikarditis Myokarditis HRS Kammerflimmern VT VHF QT-Zeit Verlängerung Magen / Darm Peritonitis Ileus Akute mesenteriale Ischämie Appendizitis Divertikulitis Cholelithiasis/Cholezystitis Choledocholithiasis/Cholangitis Akute Pankreatitis Chronische Pankreatitis Pankreaskarzinom Dysphagie Achalasie Ösophaguskarzinom GÖR Hiatushernie Gastritis Ulkuskrankheit Magenkarzinom Diarrhö Pseudomemb. kolitis CED Morbus Crohn Colotis Ulzerosa KRK Hämorroiden Leberzirrhose Virale Hepatitiden Portale Hypertension Hernie	Nephro Exsikkose Kalium Natrium Calcium Nephro - Nephritische Sd CKD ANV CKD vs ANV Akute Dialyse Cimino Zystitis Pyelonephritis Nephrolithiasis Endokrinologie DM DM1 DM2 DM Akut Km1p DM chronische kmpl Hypothyreose SDK Hyperthyreose Struma Nebenschilddrüse Nebenniere Hämato MM/MGUS Leukämie Lymphome Lymphozytose Hämorrhagische Diathese Thrombophilie Krebs Krebs Prostata Weichteilinfektion Abszess Erysipel Phlegmone Nekrotisierende Faszitis Ortho - Rheuma Frakturen Osteoporose Rückenschmerzen Bandscheibenprolaps Spondylodizitis (Endokarditis!) Morbus Bechterew Karpaltunnelsd Arthritis vs Arthrose Arthritis Arthrose Rheumatoide Arthritis Bakterielle Arthritis Gicht APS Kollagenosen SLE Sjögren DM/PM Sklerodermie Raynaud Vaskulitiden Arteiritis T. /PMR Granulomatose P.	Weitere Themen Müdigkeit Ödem SAS Todesfeststellung Strahlenschutz Sarkoïdose Hämochromatose Marfan Sd Foramen ovale Endometritis Heimgebur Tropenreise/Fieber Blutbestandteile/Hämostase Diagnostik ERCP Normal ERCP Steine ÖGD Blutung : Forrest Ileokoloskopie Ileokoloskopie M.Crohn Koloskoie Colitis U. Sono Leberzirrhose Sono Appendizitis Sono Cholezystitis Echokardiographie Endokarditis Rx Thorax Rx PNO Rx Pneumonie Rx Lungenödem Rx ARDS Rx Hiatushernie Rx Situs Inversus Rx Sarkoidose CT Angio/Kornoararterien CT Pneumonie CT Freie Luft CT Ileus CT Kopf EKG Normal VHF VTs Kammerflimmern STEMI NSTEMI Schenkelblock AV Block Labor Allgemein BGA Resp Az : COPD, Opioid Resp Alk : Hyperventiltion Metab Az : Laktat, DKA, Diarrhö Metab Alk Anämie Microzytäre Normozytäre Macrozytäre Virale Hepatitis Elektrophorese MM Leberzirrhose
Pharmako Impfungen Blutgerinnung Analgetika ATB OADs Insulin Glukokortikoide Diuretika Katecholamine PeriOp PräOp Post Op Infektions Prophylaxe Op & Antikoag PostOp Blutung Postop Fieber Stoma Wundbehandlung Nadelstichverletzung Notfall / Rea BLS ALS ALTS Abdomentrauma Thoraxtrauma SHT Opiode Intoxikation Delir SIRS/Sepsis Schock Anaphylaktischer Schock Respiratorische Insuffizienz ARDS CPAP Intubation Anämie Transfsion Massivtransfusion Blutung UGIB OGIB Akutes Abdomen Thoraxschmerz Dyspnoe Bewusstseinstörung Synkope Neuro Meningitis Krampfanfall Schlaganfall Ischämische Schlaganfall Hämorrhagische Schlaganfall Epidural & Subduralblutung Pneumo Pneumonie Lungenkarzinom COPD Asthma bronchiale Pneumothorax Pleuritis/P.erguss/P.empyem			

